

Esta obra pretende ser una crítica conceptual sistemática al discurso psiquiátrico, cuyo eje fundamental era el **cuestionamiento del paralelismo psicofísico**. Como hemos visto, el paralelismo psicofísico sostenía la dependencia de lo psíquico en relación a lo orgánico; la causa, comprobable o no, era orgánica, mientras que lo mental, era su efecto. Jaspers cuestiona fervientemente esta concepción psiquiátrica y considera que no existe una relación de subordinación de lo psíquico a lo físico, sino una relación de reciprocidad y co-dependencia, en tanto el cuerpo y el alma constituyen una unión indisoluble.

Propone entonces, trazar una distinción concreta en cuanto a los campos de saberes que competen a diferentes disciplinas que se ocupan del hombre en general. Establece un ordenamiento en cada uno de éstos: la psicología es el saber respecto de la normalidad psíquica, mientras que en el campo de la medicina, se refiere a la fisiología y a la neurología, como saberes auxiliares de la psicopatología.

Distanciándose de tal paralelismo y criticándolo, Jaspers plantea que la psicopatología estudia lo psíquico hasta los límites de la conciencia, pero en esos límites no puede hallar absolutamente ningún proceso físico que corresponda directamente a fenómenos tales como las ideas delirantes o las alucinaciones. La psicopatología se ocupará entonces de la investigación de los problemas, de los conceptos y relaciones desde los fenómenos psicopatológicos mismos. En este contexto, Jaspers plantea que el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico patológico realmente consciente. Se estudia qué y cómo experimentan los seres humanos; su vivir y las condiciones y causas de las que depende. El objeto de la psicopatología son los procesos psíquicos reales, sus condiciones, causas y consecuencias.

Ahora bien, este tipo de investigación psicopatológica tiene sus límites y es allí donde es necesaria la representación teórica de los **mecanismos extra-conscientes**, cuyo fundamento último debe buscarse en procesos corporales, sin que esto signifique que habría un paralelismo entre los procesos orgánicos y sus efectos en lo psíquico. Vemos así cómo, si bien Jaspers ya no defiende el paralelismo psicofísico, no obstante, continúa sosteniendo la existencia de una causa última radicada en procesos corporales que deben explicarse teóricamente, aunque no se los pueda captar intuitivamente.

Es importante destacar que, aun cuando la *Psicopatología general* de Jaspers data de 1913 y es por lo tanto contemporánea de la obra freudiana, Jaspers no incorpora el concepto de inconsciente de Freud y de hecho se encarga de aclarar que sus mecanismos extra-conscientes no deben ser entendidos en estos términos, ya que el concepto de inconsciente resulta ambiguo para Jaspers y es utilizado por diversos autores en sentidos heterogéneos.

El inconsciente freudiano obedece a una causalidad de representaciones y afectos que es psíquica y halla expresión en los síntomas y las distintas manifestaciones de la psicopatología de la vida cotidiana. En cambio, los mecanismos extra-conscientes de Jaspers son representaciones teóricas, hipótesis que no hallan manifestación en los síntomas, sino que son conceptos a los que se recurre cuando la captación intuitiva y comprensible del vivir humano ha encontrado sus límites. La raíz última de estos mecanismos extra-conscientes es supuesta por Jaspers en los procesos corporales.

Binomio metodológico y organización de la clínica

Su interés epistemológico por estudiar el problema de la causa conduce a Jaspers a utilizar operadores metodológicos provenientes de la filosofía: el **binomio comprensión- explicación**.

La comprensión y la explicación son los recursos metodológicos en la Psicopatología de Jaspers que permiten captar y/o explicar la patología mental: “En algunos casos, comprendemos cómo lo psíquico surge con toda evidencia de lo psíquico. Comprendemos, de este modo, único posible frente a lo psíquico, si el atacado se vuelve colérico, el amante engañado celoso, si surge de tales o cuales motivos una decisión o un hecho” (Jaspers, 1913: 35).

Al respecto, el autor distingue dos modos de la comprensión: la **comprensión estática** y la comprensión genética o explicación psicológica. La primera, también llamada fenomenológica o empática, se refiere a cualidades individuales, a los estados psíquicos de un individuo que se mantienen estables, a la representación de la vivencia particular de los enfermos tal cual se les presenta en la conciencia (por ejemplo, a quien dice “estoy contento” o “estoy triste” lo comprendemos por empatía). Es como si se tratara de una fotografía del estado psíquico en determinado momento.

La **comprensión genética**, en cambio, está referida al movimiento, a la relación entre hechos, a la captación intuitiva del engendramiento de los hechos psíquicos los unos por los otros, a la comprensión de las conexiones psíquicas. Comprendemos, según Jaspers, que quien ha tenido un hijo recientemente esté contento, o quien ha sufrido una pérdida recientemente esté triste. Lo comprensible es el terreno de lo co-vivenciable y de la empatía. Es una relación distinta de la que se establece causalmente; se trata de una “causalidad desde adentro”, es decir, de cómo los hechos psíquicos se engendran a partir de otros hechos psíquicos, mediante una concatenación de sentido.

La evidencia de estas conexiones y la empatía con esos estados se adquiere para Jaspers por la experiencia de tratar con las personalidades humanas. En la comprensión, estamos entonces en el terreno del sentido. La noción jasperiana de comprensión es fuertemente criticada por Lacan en el seminario sobre las psicosis, donde afirma que la misma:

Consiste en pensar que hay cosas que son obvias, que, por ejemplo, cuando alguien está triste se debe a que no tiene lo que su corazón anhela. Nada más falso: hay personas que tienen todo lo que anhela su corazón y que están tristes de todos modos. (Lacan, 1955-1956: 15).³⁰

La comprensión se encuentra dentro del registro del sentido, en donde las manifestaciones del fenómeno psíquico pueden ubicarse en una cadena o una sucesión de sentido. Dado que un hecho psíquico puede ser comprendido en continuidad con otro de modo evidente, es una comprensión desde adentro, es decir, desde lo psíquico. En consonancia con este planteo,

³⁰ Ver un comentario de la indicación clínica de Lacan de no comprender a los enfermos en la tercera parte.

considera que determinada vivencia produce una determinada reacción psíquica que está en estrecha relación a lo vivido.

Ahora bien, si la manifestación del fenómeno no puede ser comprendida es porque se produce una discontinuidad en el sentido y las conexiones psíquicas. Es necesario pasar al campo de la **explicación causal** (no psicológica) y para ello, Jaspers recurre a una hipótesis causal teórica, la de los mecanismos extra-conscientes. Allí donde la comprensión encuentra sus límites, surge la hipótesis de estos mecanismos. La disolución de los nexos causales, requiere del auxilio de esta hipótesis teórica que está justificada en una causalidad orgánica de base cerebral.

La explicación, a la que llama "causal", es necesaria debido al límite que presenta la comprensión como método. La explicación causal se utiliza entonces cuando el síntoma psíquico aparece como algo totalmente nuevo, incomprensible, que irrumpe en la vida psíquica. Jaspers señala que, a diferencia de la comprensión, la explicación es ilimitada. Teniendo en cuenta la limitación de la comprensión, el operador metodológico de la explicación posibilita captar la discontinuidad o ruptura en el sentido y en los nexos causales.

Ahora bien, tal binomio metodológico se corresponde –aunque no de manera exacta como más adelante lo explicitaremos- con la organización de la clínica que propone Jaspers, a saber: los **desarrollos de la personalidad** y los **procesos**.

Los **desarrollos** de la personalidad se inscriben en la concepción de Jaspers que ya señalamos previamente sobre la unión indisoluble entre cuerpo y alma, entendida como una unidad que se despliega y se realiza en una relación dialéctica con el mundo circundante.

Los desarrollos incluyen a aquellas perturbaciones que resultan mayormente comprensibles y que son concebidas como desarrollos de la personalidad. Jaspers ubica dos tipos de desarrollos: las reacciones verdaderas (o legítimas) y el desarrollo de una personalidad patológica.

El contenido de las **reacciones vivenciales patológicas** está en relación comprensible con el acontecimiento que las origina. El fenómeno psicopatológico no hubiera surgido sin este acontecimiento y su evolución depende del mismo. Existe una continuidad de sentido entre el contenido de una determinada vivencia y la respuesta de la psique. Gran parte de los desarrollos, pueden ser comprendidos en su manifestación fenomenológica a partir de su inserción en una concatenación de sentido, aunque siempre poseen una parte causal, un punto incomprensible, su alteración en lo extraconsciente, su trasposición en lo patológico (Jaspers, 1913: 446).

A su vez, Jaspers divide tales estados reactivos según:

- los motivos de la reacción: psicosis carcelaria, neurosis de renta después de accidentes, neurosis de los terremotos, neurosis de las catástrofes, entre otros;
- la estructura psíquica especial de los estados reactivos -acontecimientos a los que se responde de manera excesivamente violenta; estados de estrechamiento de la conciencia en los que se suponen reacciones repentinas; perturbación de la conciencia que produce cólera, desesperación, espanto; entre otros.
- los tipos de constitución psíquica que condicionan la reactividad.

Todos estos tipos de reacciones suponen entonces que el episodio psicótico –aunque con los mencionados límites de la comprensión- tiene un sentido: “Sirve a la defensa, a la seguridad, a la fuga, a la satisfacción de un deseo. Nace del conflicto con la realidad que, tal como es, no es tolerada más tiempo” (Jaspers, 1913: 435).

El **desarrollo de una personalidad patológica** refiere a una disposición individual que evoluciona de manera comprensible a partir de la interacción con el medio. Un ejemplo son las personalidades o caracteres paranoicos.³¹ Jaspers dice que, en la interacción con el medio, lo psíquico desarrolla una disposición individual, a la que llama “*Anlage*”. En los desarrollos anormales de la personalidad, se trata de una disposición individual, alejada del término medio de la norma. Lo patológico no está dado aquí por la ruptura, sino que esta predisposición anormal está modelada por la disposición individual; tal sería el caso por ejemplo de las frecuentemente llamadas “personas depresivas.”

Subrayemos una vez más que no todo es comprensible en los desarrollos. Por ejemplo, en las reacciones legítimas, se comprende a qué responde la reacción, pero no por qué algunos sujetos encarcelados presentan una psicosis carcelaria y otros no. Es decir, la predisposición patológica es incomprensible, por lo que debe ser explicada causalmente. Jaspers afirma:

(...) toda esta comprensión no debe sobreestimarse en su importancia. Primero, los mecanismos no pueden comprender nunca la trasposición misma; en segundo término, hay otros fenómenos anormales que los que pueden ser involucrados en una relación total comprensible; en tercer término, aun cuando el acontecimiento conmocionante interviene como factor causal, la medida de esa importancia causal es difícil de estimar. (Jaspers, 1913: 435).

Pasemos ahora al otro polo de este binomio. Los **procesos** rompen más o menos brutalmente el desarrollo de la vida mental, introduciendo un cambio psíquico totalmente nuevo. Jaspers considera que dentro de los procesos deben incluirse a las psicosis que cursan en fases o en brotes, en las que no se puede entamar el conjunto de los síntomas con el vivenciar del enfermo:

(...) el sacudimiento psíquico es sólo el último impulso eventual y superfluo por el que hace irrupción una enfermedad, sea una fase pasajera, sea el brote de un proceso, que se habría presentado finalmente también sin ese motivo, y que se desarrolla según sus propias leyes con plena independencia del motivo psíquico (Jaspers, 1913: 430).

En relación a la causa, los procesos pueden ser: orgánicos -enfermedades mentales de causas orgánicas, sólo en ellas la explicación causal puede ser cierta y localizable, es decir, una lesión-; o psíquicos, que son alteraciones permanentes de la vida psíquica, de causa desconocida. Jaspers incluye a la epilepsia, la esquizofrenia y la locura maniaco-depresiva entre los procesos psíquicos.

³¹ Cf. capítulo 16.

Los procesos psíquicos son alteraciones duraderas de la vida psíquica donde irrumpe un elemento nuevo sin causa o motivo psíquico desencadenante. Implican de este modo la irrupción de un fenómeno nuevo, que produce una discontinuidad en el campo de la significación compartida y que sólo pueden ser explicados a partir de la hipótesis causal de los mecanismos extra-conscientes. En los procesos psíquicos se pueden establecer relaciones de curso típicas, a partir de la diferencia entre **brotes y fases**, ambas con un comienzo abrupto e incomprensible.

Las fases son reversibles, hay una restitución completa de la personalidad tras la resolución, suponen un período de tiempo determinado, constituyen ciclos, tal como ocurre en la locura circular descrita por Falret, que se caracteriza por la evolución sucesiva y regular del estado maníaco, del estado melancólico y de un intervalo lúcido más o menos prolongado.³² Jaspers señala, al mismo tiempo que, aunque cada fase es pasajera, la enfermedad es crónica. Asimismo, los estados psíquicos de las fases pueden comprenderse estáticamente, como formas exageradas o disminuidas de fenómenos psíquicos conocidos. A la vez, son incomprensibles genéticamente ya que, como mencionamos, su aparición es espontánea, abrupta y disruptiva.

Los brotes, en cambio, no presentan una restitución *ad integrum*. Son característicos de la esquizofrenia.

A continuación, una breve reseña clínica de un caso de Jaspers en el que el autor puede dar cuenta claramente de la discontinuidad que se produce en los procesos, donde lo nuevo que irrumpe no puede ser ubicado en una concatenación de sentido:

La señora Kolb había tenido mucho tiempo en su oficio de costurera diversas ideas delirantes de autorreferencia. En septiembre tuvo otro presentimiento: “Me parece que tengo como un velo, creo que experimentaré pronto algo que no se todavía”. Pensaba -sin motivo- que un señor A. se casaría con ella. Cada vez le llamaba más la atención. Cuando fue el domingo a casa, le pareció como si hubiese estado alguien en la habitación y hubiese dejado algunas cosas en desorden. En la mañana del lunes diversas cosas de su trabajo no marchaban bien, y tuvo la impresión como si la cortadora le diese encargos enteramente falsos. Todas las gentes tenían algo “raro”, pero ella no sabía en qué grado. Se maravillaba de todo. El que la fuese a buscar su hermano, la llenó de alegría. Le pareció singular el que la hubiese saludado tan amablemente. En la calle le pareció que pasaba mucha gente. En la casa le dominó de repente con gran fuerza el sentimiento: tienes que quedar de pie, tienes que quedar firme, tienes que hacer algo singular. No obstante la invitación de su cuñada para que fuese a comer para que se tranquilizase y no charlase tanto, no se movió del lugar. (Jaspers, 1913: 182).

³² Cf. capítulo 20.

La crisis y el legado del paradigma

La ruptura epistemológica del tercer paradigma responde, según Lantéri-Laura (2000), a varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, la abusiva aplicación de la noción de estructura al campo de lo mental, con la consecuente pérdida de su precisión conceptual, y el deterioro que produjo en la formación clínica, en tanto los profesionales en formación dejaron de interesarse por la semiología clásica para intentar arribar a un diagnóstico estructural. En segundo lugar, la introducción del uso de los psicofármacos -neurolepticos, ansiolíticos, timolépticos, y moléculas de prolongada duración- y su utilización en la terapéutica, que produjeron notables modificaciones en la presentación de los síntomas, pero que también requerían de recuperar las variedades clínicas propias del segundo paradigma.

En tercer lugar, la proliferación de diversos y nuevos dispositivos psicoterapéuticos alternativos al psicoanálisis. Otros autores sugieren que este paradigma surge en el contexto de una cultura en la que la psiquiatría había acrecentado su injerencia “en el gobierno de las conductas cotidianas, mientras que debe negociar con las coacciones económicas y los imperativos de la filosofía neoliberal. Esto introdujo el desmembramiento de las grandes estructuras psicopatológicas.” (Gori & Del Volgo, 2008: 265-6).

La herencia de este paradigma es “un tanto ambigua” (Lantéri-Laura, 2000: 243). Por un lado, pone de manifiesto los obstáculos inherentes al abandono de una psicopatología que privilegia un diagnóstico estructural, en tanto una psiquiatría clínica que no recurre a la psicopatología puede caer en un empirismo radical. El uso de criterios pragmáticos y sindrómicos para el abordaje de los fenómenos psicopatológicos conlleva riesgos en la búsqueda de una determinada eficacia orientada por la eliminación del síntoma, sin tener en cuenta una concepción teórica que la oriente.

Referencias bibliográficas

- Bleuler, E. (1911). *La Demencia Precoz. El grupo de las esquizofrenias*. Buenos Aires: Editorial Lumen, 1993.
- Bleuler, E. (1926). La esquizofrenia. *Revista de la Asociación española de Neuropsiquiatría*, 16 (60), 1996: 663-676.
- Ey, H. (1967). Naturaleza y clasificación de las enfermedades mentales. Esbozo de una historia natural de la locura. *Revista de psicoanálisis, psiquiatría y psicología*, México, 5: 68-82.
- Gori, R., & Del Volgo, M.-J. (2008). *Exilés de l'intime. La médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique*. Paris: Editions Denoël.
- Jaspers, K. (1913). *Psicopatología general*. México: Ed. Fondo de cultura económica, 1993.
- Lantéri-Laura, G. (2000). *Ensayo sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna*, Madrid: Editorial Triacastela.

Napolitano, G. (2000). *El nacimiento de la psicopatología en la historia de la Psiquiatría*. La Plata: De La Campana, 2004.

Stagnaro, JC. (2004). Crisis de la psiquiatría. *Topía*.

Recuperado de <https://www.topia.com.ar/articulos/crisis-de-la-psiquiatr%C3%AD>